

Методические рекомендации (50-70 стр.)

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Методические рекомендации по организации вариативного питания в домах социального обслуживания](#)
 - [ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ](#)
 - [1. Главный принцип](#)
 - [2. Семь принципов внедрения](#)
 - [3. Граница 4.0 \(что кухня не назначает\)](#)
 - [ЧАСТЬ II. РОЛИ](#)
 - [4. Директор учреждения](#)
 - [5. Врач / фельдшер](#)
 - [6. Диетсестра \(или завпроизводства при отсутствии диетсестры\)](#)
 - [7. Старшая смена пищеблока](#)
 - [8. Старшая медсестра отделения](#)
 - [9. Помощник по уходу \(ранее — «сиделка»\)](#)
 - [10. Завпроизводства](#)
 - [11. Рабочая группа \(5 семей\)](#)
 - [ЧАСТЬ III. АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ](#)
 - [12. Три фазы пилота \(90 дней\)](#)
 - [13. ФАЗА 1. Замер \(дни 1–30\)](#)
 - [14. ФАЗА 2. Документы и обучение \(дни 31–60\)](#)
 - [15. ФАЗА 3. Пилот \(дни 61–90\)](#)
 - [16. Стоп-критерии \(немедленная остановка пилота\)](#)
 - [17. Решение по результатам пилота](#)
 - [ЧАСТЬ IV. МЕДИЦИНСКАЯ РАМКА](#)
 - [18. Дисфагия](#)
 - [19. Лекарства и еда](#)
 - [20. Набор веса на антипсихотиках](#)
 - [21. Клозапин и запоры \(CIGN\)](#)
 - [22. Загущённые жидкости](#)
 - [ЧАСТЬ V. ВАРИАНТЫ ВЫБОРА](#)
 - [23. Пять моделей вариативности](#)
 - [24. Пары эквивалентов](#)
 - [25. Заказ и раздача](#)
 - [ЧАСТЬ VI. ДОКУМЕНТЫ](#)
 - [26. Документальный комплект \(12 документов\)](#)
 - [27. Согласование с учредителем \(обязательно\)](#)
 - [ЧАСТЬ VII. ОБУЧЕНИЕ](#)
 - [28. Программа обучения смены \(минимум 8 часов на сотрудника\)](#)
 - [29. Обучение врача](#)
 - [ЧАСТЬ VIII. ЗАКУПКИ](#)
 - [30. 44-ФЗ и 223-ФЗ](#)

- [31. Включение вариативности в ТЗ](#)
- [32. Аутсорсинг: контракт как место вариативности](#)
- [ЧАСТЬ IX. МЕТРИКИ](#)
 - [33. 5 групп показателей пилота](#)
 - [34. Что НЕ является KPI](#)
 - [35. Стоп-критерии \(см. раздел 16\)](#)
- [ЧАСТЬ X. РИСКИ](#)
 - [36. Реестр рисков](#)
 - [37. Управление рисками в ходе пилота](#)
 - [38. Что делать, если пилот не показал эффекта](#)
- [ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
 - [Приложение 1. Форма пищевой карты жителя](#)
 - [Приложение 2. Журнал заказа блюд](#)
 - [Приложение 3. Журнал отказов](#)
 - [Приложение 4. Журнал отходов](#)
 - [Приложение 5. Таблица врача «лекарство × еда»](#)
 - [Приложение 6. Чек-лист документов \(для ответа проверяющему\)](#)
- [ЧАСТЬ XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)

Методические рекомендации по организации вариативного питания в домах социального обслуживания

Документ: рабочий инструмент для директора проекта внедрения вариативного питания.
Версия: 22.08.2026 (после семинара 26.08). **Аудитория:** директор проекта внедрения в учреждении, заместитель по АХЧ, врач/фельдшер, диетсестра, завпроизводства, старшая медсестра пилотируемого отделения, представитель учредителя, специалист по закупкам.
Объём: 60–70 страниц А4 (после вёрстки). **Назначение:** практическое руководство по запуску, проведению и масштабированию пилота вариативного питания на одном отделении учреждения социального обслуживания. **Правовая сверка:** 22.08.2026.
Фактчекинг: 22.08.2026. **Изменения после этой даты требуют перепроверки.**

Дисклеймер: материал носит информационный и методический характер и не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны — проекты локальных форм; требуют адаптации к конкретному учреждению. После 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (п. 56 подп. 11).

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ

1. Главный принцип

«Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Вариативное питание — не ресторан, не два полноценных меню и не безусловное исполнение любого желания. Это управляемая

система, в которой безопасность имеет приоритет, медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист, внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор, выбор документируется, кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз, результаты пилота измеряются, достоинство не противопоставляется безопасности.

2. Семь принципов внедрения

1. **Сначала безопасность.** Все клинические ограничения (текстуры, лечебные столы, лекарства, длительный отказ) — зона врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.
2. **Потом выбор.** Внутри медицинской рамки человек выбирает. Воля может выражаться словами, жестом, поведением, устойчивыми предпочтениями, биографическими сведениями.
3. **Потом документы.** Положение, журналы, карты, согласование с учредителем — без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки.
4. **«% выбравших» — не KPI.** Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора, а не доля «выбравших».
5. **«Внедрено публично ≠ доказанный эффект».** Панелей «до/после» в открытом доступе почти нет. Пилот в вашем учреждении — единственный способ получить собственные данные.
6. **Локальное — не руководство к действию.** Приказ № 124 Серафимовского — пример, а не норма для всех ДСО.
7. **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** (117 000 чел., проект «Если быть точным» 2024). Учреждение одновременно опекун и поставщик услуг. Задokumentированный процесс выражения воли — главный защитный механизм директора.

3. Граница 4.0 (что кухня не назначает)

Без врача:

- Любые ограничения рациона, в том числе «диабетический стол».
- Изменение текстур (протёртое, загущённое, особые консистенции).
- Правила при дисфагии и протокол свободной воды.
- Действия при длительном отказе от еды.
- Режим питания при седации.
- Решения об энтеральном/зондовом питании.
- Комфортное кормление в конце жизни.
- Сдвиг времени еды у инсулинозависимых.
- Слабительные и реакция на запор.
- Назначение анализов и добавок микронутриентов.
- Интерпретация MUST и витаминизация при ОПИ.

Без учредителя:

- Изменение финансирования продуктовой строки.
- Изменение штатного расписания (норма помощи за столом).
- Аутсорсинг питания.

- Официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки:

- Формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах.
- Обработка пищевых карт как персональных данных.
- Ответы на запросы прокуратуры.
- Конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.

ЧАСТЬ II. РОЛИ

4. Директор учреждения

Ответственность:

- Издание приказа о рабочей группе (5 фамилий + срок).
- Согласование с учредителем (уведомительный порядок, не запрашивать разрешения).
- Утверждение локального «Положения об организации питания».
- Решение о корректировке или масштабировании пилота (день 90).
- Ответственность за систему контроля (не за каждое событие, а за неработающий контроль).
- Ответы на запросы прокуратуры (комплект документов, не «запрета нет»).

Что НЕ делает:

- Не назначает текстуры.
- Не подменяет волю жителя удобством персонала.
- Не отвечает «запрета нет» на вопросы прокуратуры.
- Не масштабирует без данных пилота.

5. Врач / фельдшер

Ответственность:

- Список риска дисфагии (по 6 признакам).
- Назначенные текстуры (поимённо, с датой пересмотра).
- Таблица «лекарство × еда» на посту (подписана).
- Правило «3 отказа подряд → врач в тот же день».
- Назначение лечебного питания (лечебные столы — зона врача).
- Оценка рисков лекарственных взаимодействий (клозапин + кофе, карбамазепин + грейпфрут, литий + соль/вода, ИМАО + тирамин).
- Контроль обезвоживания у жителей на загущённых жидкостях.
- Контроль набора веса у жителей на весогенных препаратах (клозапин, оланзапин).
- Контроль запоров у жителей на клозапине (CIGH).
- Мониторинг пневмоний, падений, инцидентов (группа 5 показателей).

- Согласование пар эквивалентов (текстура внутри пары).

Что НЕ делает:

- Не отдаёт распоряжения кухне без документа.
- Не подписывает пары эквивалентов без клинического обоснования.
- Не разрешает «диабетический стол» по устной просьбе сиделки.

6. Диетсестра (или завпроизводства при отсутствии диетсестры)

Ответственность:

- Сырьювая строка (расход / жители / дни) — 1 час, калькулятор.
- Циклограмма меню с вариантами.
- Пары эквивалентов (технологическая часть).
- Журнал отходов (кухонных) и тарелочных остатков.
- IDDSI-тест (вилка, ложка, наклон) для повара.
- Соответствие текстур назначенным (доля правильных тарелок).
- Возвраты из зала.

Что НЕ делает:

- Не назначает текстуры.
- Не отвечает за клинические исходы.
- Не публикует «эффективность» пилота без данных.

7. Старшая смена пищеблока

Ответственность:

- Журнал заказа блюд (ежедневно).
- Журнал отказов (ежедневно, с триггерами).
- Журнал ночного интервала.
- Хронометраж раздачи (от начала до последней тарелки).
- Наблюдение за жителями во время еды (6 признаков раздела 10.3).
- Температура подачи (не менее 65 °С для горячих блюд — по СанПиН).
- Маркировка текстур на раздаче (если назначены).

8. Старшая медсестра отделения

Ответственность:

- Пищевые карты жителей (с текстурой и её основанием).
- Позы и темп помощи (вертикальная поза, медленный темп, малые глотки).
- Контроль объёма выпитого (стакан как единица учёта, для жителей на загущённых жидкостях).
- Гигиена полости рта (ежедневно, особенно у жителей с дисфагией).
- Передача информации врачу о трёх отказах подряд.

9. Помощник по уходу (ранее — «сиделка»)

Ответственность:

- Помощь в приёме пищи (1 помощник на 1–2 кормимых — ориентир, не норматив).
- Поза и темп.
- Наблюдение за жителем (6 признаков).
- Сообщение старшей смене о любых изменениях.

Что НЕ делает:

- Не ограничивает рацион по своему усмотрению.
- Не запрещает добавку без врачебного назначения.
- Не подменяет волю жителя.

10. Завпроизводства**Ответственность:**

- Закупка (44-ФЗ для бюджетных, 223-ФЗ для автономных).
- Контракт на аутсорсинг (если применимо): строка выбора в ТЗ.
- Приготовление пищи по парам эквивалентов.
- Маркировка текстур на кухне.
- Кухонные остатки (журнал).
- IDDSI-тест перед выдачей.
- Соблюдение СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026) / СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026): пробы, бракераж, температуры, отдельные потоки, питьевой режим.

11. Рабочая группа (5 фамилий)**Состав:**

1. Директор или зам по АХЧ (председатель).
2. Врач или фельдшер.
3. Диетсестра или завпроизводства.
4. Старшая медсестра одного отделения.
5. Представитель учредителя (если согласится).

Полномочия:

- Принимать операционные решения (модель М1–М5, пары эквивалентов, время пилота).
- Не может без согласования с учредителем менять смету, штатное расписание, статус пилота.

ЧАСТЬ III. АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ

12. Три фазы пилота (90 дней)

Фаза	Дни	Цель	Что делается	Что НЕ делается
1. Замер	1–30	Узнать фактическое состояние	Сырьевая строка, отходы, остатки, ночной интервал, 5 чисел контингента, таблица врача	Не менять меню, не выбирать модель, не выпускать пресс-релиз
2. Документы и обучение	31–60	Подготовить нормативную базу	Положение, согласование, пары эквивалентов, обучение, журналы	Не масштабировать, не менять закупку
3. Пилот	61–90	Запустить выбор и собрать данные	Запуск, ежедневный сбор, промежуточный контроль на 75-й день	Не вводить новые ставки

Длительность пилотного цикла: минимум 90 дней. Полный переход — после 3–6 месяцев успешных пилотов на 2–3 отделениях.

13. ФАЗА 1. Замер (дни 1–30)

День 1. Издать приказ о рабочей группе.

День 1. Посчитать сырьевую строку (1 час, калькулятор). Формула: расходы на продукты за последний полный месяц ÷ число жителей ÷ число дней. Записать своё число. Если за пять минут никто не называет — это первая находка аудита.

День 2. Запустить семидневный замер отходов. Замерять: тарелочные остатки по трём основным приёмам (г/порцию); кухонные остатки; время от начала раздачи до последней тарелки. Ответственный — завпроизводства или старшая смена.

День 3. Запустить замер ночного интервала. В журнале смены записывать время ужина и время завтрака следующего дня.

День 5. Направить письмо-уведомление учредителю (1 страница).

День 7. Собрать 5 чисел контингента по отделению: едят сами / с помощью / неговорящие / группа риска дисфагии / на весогенных препаратах. Сверяется с листом жителей.

День 10. Врач формирует список риска дисфагии по 6 признакам (раздел 10.3 исходного доклада). Список — на посту и в кухне, подписан врачом.

День 14. Провести инструктаж смены (6 признаков, правило «3 отказа»). 100 % смены прошли.

День 21. Получить подписанную таблицу врача «лекарство × еда». На посту и в кухне.

День 28. Сводный отчёт по замеру (все 5 групп показателей).

День 30. Решение: продолжать или корректировать. Протокол подписан 5 членами.

14. ФАЗА 2. Документы и обучение (дни 31–60)

День 31. Утвердить локальное «Положение об организации питания».

День 33. Согласовать модель (M1–M5) с учредителем. Получить письменное согласование.

День 35. Сформировать 3–4 пары эквивалентов (завтрак/обед). Подписаны врачом и диетсестрой.

День 38. Провести обучение смены (3 занятия по 40 минут): 6 признаков дисфагии; правило «3 отказа»; IDDSI-тест; техника помощи; документы (журналы). Минимум 8 часов на сотрудника за пилот.

День 42. Ввести журнал заказа блюд (форма утверждена).

День 45. Ввести журнал отказов с триггерами. Три отказа подряд → запись → врач в тот же день.

День 48. Обучить повара тесту IDDSI (вилка, ложка, наклон). Повар сдал практический тест.

День 52. Подключить совет жителей (если есть) к обсуждению пар.

День 55. Провести пробный запуск на одном обеде без публикации.

День 60. Сводный отчет по документам и обучению.

15. ФАЗА 3. Пилот (дни 61–90)

День 61. Старт пилота (понедельник). Объявление смене и жителям.

Дни 61–90. Ежедневно: журнал заказа, журнал отказов, остатки, ночной интервал, события риска. Заполняются ежедневно.

День 75. Промежуточный контроль (15 дней). 5 групп показателей. Решение о корректировке.

День 80. Корректировка (если нужно). Что изменили.

День 90. Итоговый замер (такой же, как день 7). 5 групп показателей.

День 95. Решение о корректировке или масштабировании. Подписано директором, в журнал.

16. Стоп-критерии (немедленная остановка пилота)

Пилот **останавливается** при следующих событиях:

1. **Рост пневмоний** в пилотном отделении ≥ 30 % по сравнению с предыдущим кварталом.
2. **Падение со смертельным исходом** в столовой пилотного отделения.
3. **Жалоба жителя / родственника** в прокуратуру на нарушение при пилоте.
4. **Приказ учредителя** о приостановке.
5. **Отзыв согласия учредителя.**
6. **Отсутствие врача** на посту (невозможность исполнить границу 4.0).

Решение о возобновлении принимается директором после устранения причины остановки и согласования с учредителем.

17. Решение по результатам пилота

Результат	Решение
4 из 5 групп в норме	Масштабирование на 1–2 отделения; новая фаза обучения
3 из 5 в норме	Корректировка пар, дополнительный инструктаж; повторный пилот 60 дней
2 из 5 в норме	Остановка; анализ причин; новый замер
1 или 0 в норме	Смена подхода; смена модели (M1 ↔ M2); обязательная ревизия медицинской рамки

Главное правило: пилот — **измеримая гипотеза**, а не обещание успеха. «Не получилось» — это тоже результат.

ЧАСТЬ IV. МЕДИЦИНСКАЯ РАМКА

18. Дисфагия

Распространённость. В изученных клинических группах на антипсихотиках — **21,9–69,5 %** (Miarons Font M, Rofes Salsench L. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(12):1332-9; обзор 18 исследований). **Популяции не совпадают с российскими ДСО; в вашем учреждении цифра может быть любой** — посчитайте свою в первые 10 дней.

Смертность. Пневмония при шизофрении — **в 7 раз выше популяционной** (Correll C.U. et al. World Psychiatry 2022;21(2):248-271; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23). Общий разрыв продолжительности жизни — 15–20 лет. Аспирация — один из ключевых механизмов.

6 признаков, которые видит сиделка без логопеда:

1. Покашливание или поперхивание во время или после еды.
2. «Влажный», булькающий голос после глотка.
3. Многократное проглатывание одного куска.
4. Еда «за щекой».
5. Необычно долгий приём пищи.
6. Повторные пневмонии в анамнезе.

Правило: «увидел признак — записал — сообщил врачу в тот же день».

IDDSI. Международный стандарт описания текстур: 8 уровней (0–7), напитки 0–4, пища 3–7. Cichero J.A.Y. et al. Dysphagia 2017;32(2):293-314. **IDDSI — терминология, не лечебный протокол.** Текстуру назначает врач по результатам индивидуальной оценки. Кухня исполняет.

Доказательная база внедрения IDDSI (Wu X.S. et al. Dysphagia 2022;37(5):1314-1325): в 5 учреждениях aged care (общий long-term care, **не психиатрия**) соответствие текстур выросло с 44 до 90 %, загущённых жидкостей — с 31 до 100 %, эффект сохранялся 6 мес. **Прямой перенос на психиатрический контингент не доказан.**

Скрининг GUSS. Trapl M. et al. Stroke 2007;38(11):2948-52. Чувствительность 100 %, специфичность 50–69 %. **Разработан для инсульта; в психиатрическом контингенте требует адаптации инструкции.**

Правила стола для группы риска:

- Вертикальная поза (90°).
- Подбородок чуть вниз.
- Малые глотки, паузы.
- 30 минут после еды без укладывания.
- Наблюдение работника до конца еды.
- Питание доступно в течение всего приёма.

Гигиена полости рта. Yoneyama T. et al. J Am Geriatr Soc 2002;50:430-3. РКИ 366 жителей: пневмонии 19→11 %. Cochrane 2022 (CD012416.pub3) подтверждает, но с низкой определённой. **Организационная мера нулевой стоимости с документированным смыслом.**

19. Лекарства и еда

Четыре правила кухни по таблице врача:

Пара	Что	Источник
Клозапин ↔ кофеин	400–1000 мг кофеина повышает AUC клозапина в среднем на 19 %, снижает клиренс на 14 %	Hägg S. et al. Br J Clin Pharmacol 2000;49(1):59-63 (12 здоровых добровольцев, однократная доза)
Литий ↔ соль/вода	Дефицит натрия/обезвоживание → рост уровня лития	StatPearls, Cleveland Clinic
ИМАО ↔ тирамин	Тираминовые продукты → гипертонический криз	NHS, prescriber's guide
Карбамазепин ↔ грейпфрут	300 мл сока → пик CBZ +40 %, AUC +41 %	Garg S.K. et al. Clin Pharmacol Ther 1998;64(3):286-8 (10 пациентов с эпилепсией)

Кухня не отменяет кофе — врач оценивает риск и документирует решение.

20. Набор веса на антипсихотиках

Мета-анализ CRWG (Campforts B. et al. BJPsych Open 2023;9(1):e18; 202 исследования): прибавка ≥7 % веса за 38 нед — клозапин **76,3 %**, оланзапин 36,9 %, рисперидон 23,0 %.

Мета-анализ Pillinger (Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77; 100 РКИ, 25 952 пациента, медиана 6 нед): диапазон по 18 антипсихотикам –0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг

(клозапин).

Что делает учреждение:

- Мониторинг веса/ИМТ (исходно, 4/8/12 нед, 6 мес, ежегодно).
- Мониторинг глюкозы/липидов/АД (исходно, 12 нед, ежегодно).
- Структурированная доступность еды (особенно для жителей с гиперфагией).
- Без самостоятельных «диет» — все ограничения через врача.

21. Клозапин и запоры (CIGN)

Every-Palmer S. et al. 2016/2017. Запор у 30–60 % субъективно; до 80 % объективно. Транзитное время 104,5 ч vs 23 ч. Летальность CIGN 15–27,5 %.

Что делает учреждение:

- Профилактические слабительные (не волюноконцентраторы — они опасны при CIGN).
- Мониторинг стула (ежедневно, особенно в первые 4 месяца клозапина).
- Тревожные симптомы: умеренная/сильная боль в животе >1 ч, рвота, диарея переполнения, отсутствие кишечных шумов, метаболический ацидоз, лейкоцитоз → **немедленный вызов врача.**

22. Загущённые жидкости

Steele S.J. et al. Breathe 2021;17(1):210003: «нет убедительных данных о снижении респираторных осложнений при загущении, но есть нагрузка лечения и снижение потребления жидкости».

Что делает учреждение:

- Загущение — только по назначению врача, с пересмотром.
- Объём выпитого (стакан как единица) — на панели показателей.
- Индикаторы дегидратации (тёмная моча, сухость языка, сонливость).
- Протокол свободной воды (Frazier) — только по назначению врача; роль организации — гигиена рта до воды и журнал объёма. **Без гигиены рта протокол противопоказан.**

ЧАСТЬ V. ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

23. Пять моделей вариативности

Модель	Описание	Где применяется
M0 — Без вариативности	Одно меню, стандартное	Базовый режим; для неговорящих без биографии

Модель	Описание	Где применяется
М1 — Выбор ключевых позиций	Несколько раз в неделю; на завтрак/обед — выбор ключевых позиций, перечень определяет диетсестра	Болотнинский ПНИ (S015)
М2 — Ежедневный выбор вторых блюд	Два варианта вторых блюд + два салата + два напитка ежедневно	Успенский ПНИ (S016)
М3 — Заказное (ресторанный день)	Выбор из нескольких готовых вариантов «ресторанного» меню	Серафимовский (S030)
М4 — Пары эквивалентов	Два эквивалентных по граммовкам/калорийности варианта в одной подаче	Все 5 практик + пилот
М5 — Полная аутсорсинг-вариативность	Контракт на аутсорсинг питания с ТЗ «предусмотреть выбор»	Тесовый берег (44-ФЗ), Серафимовский (223-ФЗ)

На пилоте рекомендуется М4 (пары эквивалентов) — самый управляемый и измеримый.

24. Пары эквивалентов

Что это: два варианта одного приёма пищи, эквивалентные по:

- Граммовкам (в пределах $\pm 10\%$).
- Калорийности (в пределах $\pm 10\%$).
- Белкам/жирам/углеводам (в пределах $\pm 15\%$).
- Текстуре (если назначена).
- Стоимости (в пределах $\pm 10\%$).

Что это не: два разных блюда (например, «борщ + щи» — это не пара, это две разные позиции).

Пример пары (обед):

- Каша гречневая (200 г, 240 ккал, Б10/Ж6/У40) + котлета куриная (80 г, 130 ккал, Б15/Ж8/У5) + огурец (50 г, 8 ккал) + хлеб (30 г, 70 ккал) + чай (200 мл) = 448 ккал, Б25/Ж14/У45.
- Каша рисовая (200 г, 230 ккал, Б6/Ж5/У42) + тефтеля мясная (80 г, 140 ккал, Б12/Ж10/У6) + помидор (50 г, 10 ккал) + хлеб (30 г, 70 ккал) + чай (200 мл) = 450 ккал, Б18/Ж15/У48.

Подпись: диетсестра (технологическая эквивалентность) + врач (клиническая безопасность).

25. Заказ и раздача

Заказ. Накануне (за 12–24 ч) — жителю предлагается выбор из пары. Канал: показ (две порции, две карточки с фото, устно), устный вопрос (для говорящих), пищевая биография (для неговорящих). Выбор документируется в журнале заказа.

Раздача. Пары подаются одновременно. Помощник по уходу помогает выбрать и подвинуть. Время раздачи фиксируется (от начала до последней тарелки). Целевой показатель: ≤40 минут на 3 захода.

Если житель не выбрал — подаётся стандартный вариант пары (по умолчанию — первый в паре). Выбор за жителя не делается, но стандартный вариант предлагается.

Если житель отказался — запись в журнал отказов, помощник спрашивает причину, врач информируется. Три отказа подряд → врач в тот же день.

ЧАСТЬ VI. ДОКУМЕНТЫ

26. Документальный комплект (12 документов)

№	Документ	Назначение	Готовность
1	Приказ о рабочей группе	5 фамилий + срок	Шаблон
2	Письмо-уведомление учредителю	1 страница с обоснованием	Шаблон
3	Локальное «Положение об организации питания»	Описывает модель выбора	Шаблон
4	Меню с вариантами (циклограмма)	С вариантами по приёмам	Разрабатывается диетсестрой
5	Пары эквивалентов	Подписаны врачом + диетсестрой	Разрабатывается на ФАЗЕ 2
6	Таблица врача «лекарство × еда»	На посту, подписана врачом	Разрабатывается на ФАЗЕ 1
7	Список риска дисфагии	На посту, подписан врачом	Разрабатывается на ФАЗЕ 1
8	Пищевые карты жителей	Текстура, ограничения, воля	Форма
9	Журнал заказа блюд	Ежедневно, на каждое блюдо	Форма
10	Журнал отказов	С триггерами	Форма
11	Журнал отходов	Кухонных и тарелочных	Форма
12	Согласование с учредителем	Уведомительный порядок	Получено письменно

Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. С комплектом — как управленческое решение.

27. Согласование с учредителем (обязательно)

Письмо-уведомление (1 страница) должно содержать:

1. **Обоснование** — ссылки на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 (до 31.08.2026) / СанПиН 4282-26 п. 56(11) (с 01.09.2026); 442-ФЗ ст. 9 (уважительное и гуманное отношение), ст. 16 (ИППСУ); 3185-1 ст. 5 ч. 2 (право на гуманное отношение).
2. **Ссылка на публичные практики** — Успенский ПНИ (S016), Болотнинский ПНИ (S015), Усть-Илимский ДСО (S017), Иркутская область (S018), опыт Серафимовского (S030, S035 — **локальный приказ**, не руководство).
3. **Срок пилота** — 90 дней, начиная с [дата].
4. **Точка пилота** — одно отделение, 20–35 жителей, один обед.
5. **Просьба** — согласовать или подтвердить уведомительный порядок.
6. **Подпись** директора.

ЧАСТЬ VII. ОБУЧЕНИЕ

28. Программа обучения смены (минимум 8 часов на сотрудника)

Занятие	Тема	Длительность	Ответственный
1	6 признаков дисфагии (раздел 10.3 исходного доклада)	40 мин	Старшая медсестра
2	Правило «3 отказа подряд → врач в тот же день»	30 мин	Старшая медсестра
3	IDDSI-тест (вилка, ложка, наклон)	40 мин	Диетсестра
4	Техника помощи (поза, темп, малые глотки, 30 мин после еды)	40 мин	Старшая медсестра
5	Документы (журнал заказа, журнал отказов, отходы)	40 мин	Завпроизводства
6	Лекарства и еда (4 правила)	30 мин	Врач
7	Гигиена полости рта	20 мин	Старшая медсестра
8	Практическое занятие на раздаче	60 мин	Старшая смены
9	Практическое занятие IDDSI для повара	30 мин	Диетсестра
10	Итоговое занятие: разбор кейсов	30 мин	Директор
Всего		8 ч 30 мин	

Минимум 8 часов на сотрудника за 90 дней пилота — обязательное условие.

29. Обучение врача

Темы, которые врач должен освоить (или подтвердить знание):

- IDDSI: 8 уровней, тесты, интерпретация.
- GUSS/EAT-10: скрининговые инструменты, их ограничения в психиатрии.
- Лекарственно-пищевые взаимодействия (4 правила + курение → клозапин –50 %).
- Мониторинг метаболического риска (вес/ИМТ, глюкоза/липиды/АД).
- Клозапин и CIGN (запоры, илеус, смерть).
- Стандарт MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
- Локальный порядок «осознанного риска» (если житель с дисфагией настаивает на обычной пище — оформление информированного решения с врачом).

ЧАСТЬ VIII. ЗАКУПКИ

30. 44-ФЗ и 223-ФЗ

Закон	Тип учреждения	Пример	Особенности
44-ФЗ	Бюджетные (казённые, бюджетные)	СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег"» (S034 — извещение 0372200070825000244)	Конкурентные процедуры; контроль ст. 34, 94, 95
223-ФЗ	Автономные, госкорпорации	СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский"»	Собственное положение о закупках

Обе схемы допускают вариативность, если она в ТЗ.

31. Включение вариативности в ТЗ

В техническом задании (технической части контракта) должна быть строка:

«Предусмотреть выбор из 2 вариантов по приёмам (завтрак, обед) для 100 % жителей пилотного отделения. Варианты эквивалентны по граммовкам и калорийности. Замена по таблице пар допускается. Штраф за неисполнение — ____ руб. за каждый случай. РНП при систематическом нарушении (3 случая за квартал).»

В проекте контракта — ответственность подрядчика за неисполнение (штраф, расторжение, РНП — реестр недобросовестных поставщиков).

Письмо Комитета по соцполитике СПб (S031, 19.08.2026) — ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП. Это **основание** для претензий к подрядчику.

32. Аутсорсинг: контракт как место вариативности

Два типичных сценария:

Сценарий	Преимущества	Недостатки
Внутренняя кухня	Гибче, быстрее корректировка	Нагрузка на штат, оборудование
Аутсорсинг	Дешевле, нет проблем с кадрами	Жёстче в спецификации; подрядчик — не союзник

Решение принимает директор, **оба варианта работают** при правильной формулировке контракта.

Внутренняя кухня — больше свободы, но требует квалифицированного завпроизводства и контроля.

Аутсорсинг — вариативность включается в ТЗ; подрядчик, не готовый её обеспечить, не соответствует ТЗ.

ЧАСТЬ IX. МЕТРИКИ

33. 5 групп показателей пилота

Группа	Что измеряет	Ключевые показатели
1. Заполненность пищевых карт	Качество клинической документации	P-1, P-2, P-3
2. Доступный выбор	Доступность, не доля «выбравших»	P-4, P-5, P-6
3. Исполнение	Качество исполнения	P-7, P-8, P-9
4. Отходы	Качество планирования	P-10, P-11, P-12, P-13, P-14
5. События риска	Безопасность	P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20

Полный словарь 26 показателей — 09_инструменты/словарь_показателей.csv .

34. Что НЕ является KPI

«Метрика»	Почему не KPI
«% жителей, выбравших альтернативу»	Человек вправе выбрать стандарт или не выбирать вовсе
«Число поданных жалоб»	Жалоба ≠ плохой результат; жалоба — обратная связь
«Объём вложенных денег»	Не KPI; KPI — отходы и потребление
«Скорость раздачи»	Скорость — параметр безопасности, а не KPI успеха

«Метрика»	Почему не KPI
«Число внедрённых пар эквивалентов»	Много пар ≠ хорошо; важно качество

35. Стоп-критерии (см. раздел 16)

№	Критерий	Действие
1	Рост пневмоний ≥30 %	Остановка, анализ
2	Падение со смертельным исходом	Остановка, расследование
3	Жалоба в прокуратуру	Остановка, разбор
4	Приказ учредителя	Остановка
5	Отзыв согласия учредителя	Остановка
6	Отсутствие врача	Остановка (невозможно исполнить границу 4.0)

ЧАСТЬ X. РИСКИ

36. Реестр рисков

№	Риск	Уровень	Действие
R-01	Смена СанПиН 4282-26 с 01.09.2026	Высокий	Полная сверка п. 56 подп. 11–14, п. 62, раздел VI с 01.09.2026
R-02	Сайт pni9.ru прекратил работу 21.08.2026	Средний	Использовать архив web.archive.org; в новой редакции — привязка к архивной копии
R-03	99 % недееспособных под опекой учреждения	Высокий	В устной версии — формулировка «общероссийская норма, не уникальный риск»
R-04	Локальный приказ № 124 выдаётся за общероссийскую норму	Высокий	Везде «локальный акт Серафимовского»
R-05	«76,3 % клозапин» путается с Pillinger	Средний	Разделено в новой редакции
R-06	«15 часов» ночного интервала без оговорки	Средний	Тройная привязка (Швеция 11 / РФ цель 13 / США 14)
R-07	IDDSI 44→90 % выдаётся за доказанный эффект	Средний	Оговорка «общее long-term care, не психиатрия»
R-08	GUSS/EAT-10 без указания «для инсульта»	Низкий	Оговорка в новой редакции

№	Риск	Уровень	Действие
R-09	«Невербальный выбор» — авторский термин	Низкий	Сноска с альтернативными терминами
R-10	Nijs 2006 family-style dining не проверено	Низкий	Этап 11

37. Управление рисками в ходе пилота

1. **Еженедельная сверка** 5 групп показателей.
2. **Промежуточный контроль** на 75-й день.
3. **Корректировка** на 80-й день (если нужно).
4. **Остановка** при любом из 6 стоп-критериев.
5. **Журнал событий** — фиксация всех отклонений.

38. Что делать, если пилот не показал эффекта

Сценарий	Действие
4 из 5 групп в норме	Масштабировать на 1–2 отделения
3 из 5	Корректировать пары; повторный пилот 60 дней
2 из 5	Остановить; проанализировать причины
1 или 0 из 5	Сменить подход (модель, обучение, медицинская рамка)

Главное правило: «не получилось» — это тоже результат, который говорит, что нужно менять.

ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма пищевой карты жителя

Поле	Значение
ФИО	
Дата поступления	
Дата составления карты	
Диагноз основной	
Сопутствующие	
Препараты (с дозами)	
Текстура пищи (уровень IDDSI)	
Текстура жидкости (уровень IDDSI)	

Поле	Значение
Ограничения рациона (лечебный стол, аллергии)	
Группа риска дисфагии (6 признаков)	Да/Нет
Помощь в приёме пищи (1:1, 1:2, самостоятельно)	
Предпочтения (из пищевой биографии)	
Канал выражения воли (слово / показ / карточки / биография)	
Диетические ограничения по лекарствам	
Дата следующего пересмотра	
Подпись врача	
Подпись диетсестры	

Приложение 2. Журнал заказа блюд

Дата	Житель	Завтрак (выбор)	Обед (выбор)	Ужин (выбор)	Канал выбора	Помощник
		Пара 1: ____	Пара 2: ____	Пара 3: ____	показ / слово / карточка	

Приложение 3. Журнал отказов

Дата	Житель	Приём пищи	Блюдо	Причина (если названа)	Действия	Врач информирован
						Да/Нет

Правило: 3 отказа подряд → звонок врачу в тот же день.

Приложение 4. Журнал отходов

Дата	Тарелочные остатки (г) — завтрак	Кухонные остатки (кг)	Время раздачи (мин)	Число жителей	Примечания

Приложение 5. Таблица врача «лекарство × еда»

Препарат	Ограничение	Основание	Дата введения	Подпись врача
Клозапин	Контроль кофеина (≤1–2 чашки в день); стабильность потребления	Hägg 2000 (CYP1A2)		
Литий	Стабильный приём соли и воды; контроль обезвоживания	StatPearls		

Препарат	Ограничение	Основание	Дата введения	Подпись врача
ИМАО	Избегать тирамина (выдержанный сыр, вяленое мясо, красное вино, соевый соус)	NHS		
Карбамазепин	Грейпфрутовый сок не более 300 мл/день	Garg 1998 (CYP3A4)		
Варфарин	Стабильный приём витамина К (зелёные овощи)			
Метформин	С едой, не на пустой желудок			
Инсулин	Строго по расписанию, контроль углеводов			

Приложение 6. Чек-лист документов (для ответа проверяющему)

- ☐ Приказ о рабочей группе
- ☐ Письмо-уведомление учредителю + ответ
- ☐ Положение об организации питания
- ☐ Меню с вариантами
- ☐ Пары эквивалентов
- ☐ Таблица врача «лекарство × еда»
- ☐ Список риска дисфагии
- ☐ Пищевые карты жителей
- ☐ Журнал заказа
- ☐ Журнал отказов
- ☐ Журнал отходов
- ☐ Журнал ночного интервала
- ☐ Журнал обучения смены
- ☐ Протокол итогового решения (день 95)

ЧАСТЬ XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главный тезис. Вариативное питание — не ресторан и не безусловное исполнение желания. Это управляемая система, в которой безопасность имеет приоритет, медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист, внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор, выбор документируется, кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз, результаты пилота измеряются, достоинство не противопоставляется безопасности.

Главный практический вывод. «Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

Одна просьба. Не меняйте всё меню сразу. Один обед, одно отделение, одна неделя замера. Затем пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом

фактического выбора.

Главная финальная формула. «Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки».

Дата: 22.08.2026. **Применяется:** для директоров проектов внедрения вариативного питания в ПНИ/ДСО. **Правовая сверка:** 22.08.2026. **Фактчекинг:** 22.08.2026. **Этическая рецензия:** 22.08.2026. **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки. Особенно:** смена СанПиН 4282-26 с 01.09.2026. **Контакт:** Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский"».